चिकित्सीय आहार: अल्सर एवं पेप्टिक रोग

Therapeutic Diet: Ulcers and Peptic Disease

अल्सर (Ulcer) ऊतक में बनने वाला घाव है। इस अध्याय में मुख्य रूप से आमाशय और ग्रहणी के पेप्टिक अल्सर तथा उनसे संबंधित आहार-व्यवस्था का अध्ययन किया गया है।

पेप्टिक अल्सर में अम्ल-पेप्सिन की क्रिया और श्लेष्मिक सुरक्षा के बीच संबंध महत्त्वपूर्ण है। रोग का उपचार उसके कारण पर आधारित होता है; आहार का उद्देश्य पर्याप्त पोषण और भोजन-सहनशीलता बनाए रखना है।

अध्ययन के प्रमुख आधार (Key Areas)

आधार	अध्ययन का विषय
रोग का स्वरूप	आमाशयी और ग्रहणी संबंधी अल्सर
कारण	एच. पाइलोरी संक्रमण और कुछ दवाएँ
पोषण	ऊर्जा, प्रोटीन और खाद्य विविधता
सहनशीलता	भोजन की मात्रा, बनावट और व्यक्तिगत लक्षण
स्वास्थ्यलाभ	उपचार, निगरानी और पर्याप्त भोजन

आहार की भूमिका (Role of Diet)

एक ही विशेष भोजन या सार्वभौमिक पाबंदी अल्सर का उपचार नहीं है। जिस पदार्थ से परेशानी बढ़ती हो, उसमें उचित बदलाव करते हुए संतुलित आहार दिया जाता है।

> लक्षण में अस्थायी आराम, पर्याप्त पोषण और अल्सर का ठीक होना अलग बातें हैं। इनका मूल्यांकन अलग-अलग करना आवश्यक है।

1. पेप्टिक अल्सर का अर्थ और प्रकार

Meaning and Types of Peptic Ulcers

पेप्टिक अल्सर (Peptic Ulcer) पाचन-मार्ग की श्लेष्मिक परत में बनने वाला ऐसा घाव है जो अम्ल और पेप्सिन के संपर्क वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सामान्य स्थान आमाशय और ग्रहणी हैं।

पद	अर्थ
आमाशयी अल्सर (Gastric Ulcer)	आमाशय में घाव; गैस्ट्रिक अल्सर
ग्रहणी का अल्सर (Duodenal Ulcer)	छोटी आँत के प्रारंभिक भाग में घाव; ड्यूडेनल अल्सर
अपरदन (Erosion)	अपेक्षाकृत सतही क्षति; इरोजन
पेप्टिक अल्सर रोग (PUD)	अल्सर से संबंधित रोग-अवस्था

गहराई का अंतर (Depth of the Lesion)

अपरदन की तुलना में अल्सर गहरा होता है। अल्सर श्लेष्मिक परत की पतली पेशीय सीमा से नीचे तक पहुँच सकता है। यह केवल सतह की हल्की जलन का नाम नहीं है।

शब्दों की स्पष्टता (Terminology)

मुँह, त्वचा और अन्य अंगों में भी अल्सर हो सकता है। उन सभी का कारण तथा आहार-प्रबंधन पेप्टिक अल्सर जैसा नहीं होता।

> “अल्सर” घाव का सामान्य पद है; “पेप्टिक अल्सर” उसके स्थान और रोग-प्रक्रिया से जुड़ा विशिष्ट पद है।

2. आमाशय, ग्रहणी और पाचक स्राव

Stomach, Duodenum and Digestive Secretions

आमाशय (Stomach) भोजन को संग्रहीत, मिश्रित और प्रारंभिक रूप से पचाने में योगदान देता है। ग्रहणी (Duodenum) छोटी आँत का प्रारंभिक भाग है, जहाँ आगे के पाचन में अनेक स्राव योगदान देते हैं।

घटक	मुख्य योगदान
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)	अम्लीय वातावरण और पेप्सिन की क्रिया में सहायता
पेप्सिन (Pepsin)	प्रोटीन के पाचन में योगदान
म्यूकस (Mucus)	श्लेष्मिक सतह पर सुरक्षा
बाइकार्बोनेट (Bicarbonate)	सतह के निकट अम्ल के प्रभाव को सीमित करना
ग्रहणी के स्राव	अम्लीय पदार्थ के निष्प्रभावन में सहायता

सामान्य क्रिया और रोग (Normal Function and Disease)

अम्ल सामान्य पाचन का भाग है। रोग समझने के लिए केवल अम्ल की उपस्थिति नहीं, सुरक्षा और मरम्मत की स्थिति भी देखनी चाहिए।

भोजन से संबंध (Relation to Food)

भोजन का आकार, संरचना और समय आमाशय के कार्य तथा महसूस होने वाले लक्षण बदल सकते हैं। इससे किसी पदार्थ को अल्सर का मूल कारण नहीं माना जा सकता।

> अम्ल आवश्यक पाचक स्राव है; श्लेष्मिक सुरक्षा कमजोर होने पर वही वातावरण ऊतक-क्षति में योगदान दे सकता है।

3. श्लेष्मिक सुरक्षा और ऊतक-क्षति

Mucosal Defence and Tissue Injury

आमाशय की भीतरी सतह में ऐसे तंत्र होते हैं जो अम्लीय वातावरण के बावजूद उसकी सुरक्षा और मरम्मत में योगदान देते हैं।

सुरक्षा का पक्ष	योगदान
म्यूकस-बाइकार्बोनेट परत	सतह पर अम्ल का प्रभाव सीमित करना
कोशिकीय अवरोध (Cellular Barrier)	ऊतक की अखंडता बनाए रखना
रक्त प्रवाह (Blood Flow)	ऑक्सीजन, पोषण और मरम्मत
प्रोस्टाग्लैंडिन (Prostaglandins)	सुरक्षा और श्लेष्मिक कार्यों में योगदान
कोशिकीय मरम्मत (Cell Repair)	क्षतिग्रस्त क्षेत्र की भरपाई

संतुलन बिगड़ना (Impaired Balance)

संक्रमण या कुछ दवाएँ सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हैं। इससे अम्ल-पेप्सिन की क्रिया के प्रति ऊतक अधिक संवेदनशील हो सकता है।

केवल अधिक अम्ल नहीं (Beyond Acid Secretion)

हर अल्सर में अत्यधिक अम्ल-स्राव होना अनिवार्य नहीं है। पर्याप्त सुरक्षा का अभाव भी रोग-प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण भाग है।

> पेप्टिक रोग को आक्रामक कारकों, सुरक्षा और मरम्मत के संबंध में समझें; केवल “अम्ल अधिक है” कहना अधूरा विवरण है।

4. एच. पाइलोरी संक्रमण

H. pylori Infection

हेलिकोबैक्टर पाइलोरी (Helicobacter pylori) को संक्षेप में एच. पाइलोरी कहा जाता है। यह जीवाणु आमाशय की श्लेष्मिक परत में रह सकता है और पेप्टिक अल्सर का प्रमुख कारण है।

आधार	प्रमुख बात
प्रकृति	जीवाणुजनित संक्रमण
संबंध	श्लेष्मिक सूजन और सुरक्षा में बदलाव
परिणाम	कुछ संक्रमित व्यक्तियों में अल्सर
पहचान	उपयुक्त चिकित्सकीय परीक्षण
प्रबंधन	संक्रमण उपस्थित हो तो उसका उपचार

संक्रमण और रोग का अंतर (Infection and Disease)

एच. पाइलोरी से संक्रमित हर व्यक्ति में अल्सर नहीं बनता। संक्रमण, व्यक्ति की स्थिति और अन्य कारक मिलकर परिणाम प्रभावित करते हैं।

भोजन की सीमा (Limits of Food-Based Measures)

दही, लहसुन, फल-रस या कोई अन्य सामान्य खाद्य पदार्थ प्रमाणित संक्रमण-उन्मूलन उपचार का विकल्प नहीं है।

उपचार के बाद (After Treatment)

लक्षण घटने से संक्रमण समाप्त होने की निश्चित पुष्टि नहीं होती। उचित समय पर उपचार की सफलता का परीक्षण आवश्यक हो सकता है।

> संक्रमण की पहचान और उन्मूलन रोग के कारण से संबंधित हैं; आहार में बदलाव मुख्यतः पोषण और सहनशीलता से संबंधित है।

5. दर्दनाशक दवाएँ और अल्सर

Pain Medicines and Ulcer Risk

कुछ गैर-स्टेरॉइडल सूजनरोधी दवाएँ, जिन्हें NSAIDs (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs) कहा जाता है, पेप्टिक अल्सर का प्रमुख कारण हैं। इनमें एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नैप्रोक्सेन जैसे उदाहरण आते हैं।

पक्ष	अर्थ
श्लेष्मिक प्रभाव	सुरक्षा और मरम्मत प्रभावित हो सकती है
लंबे समय का उपयोग	जोखिम बढ़ सकता है
अधिक मात्रा या कई दवाएँ	अतिरिक्त जोखिम हो सकता है
पूर्व अल्सर	चिकित्सकीय समीक्षा का महत्त्व

तंत्र का आधार (Mechanism)

इन दवाओं से प्रोस्टाग्लैंडिन-निर्माण कम हो सकता है। इससे आमाशय की श्लेष्मिक सुरक्षा प्रभावित होती है।

भोजन के साथ लेने की सीमा (Taking Medicines with Food)

दवा को भोजन के साथ लेने से कुछ असुविधा घट सकती है, लेकिन उससे अल्सर का पूरा जोखिम समाप्त नहीं होता।

दवा की समीक्षा (Medication Review)

निर्धारित दवा, विशेषकर हृदय संबंधी कारण से दी गई एस्पिरिन, स्वयं बंद न करें। आवश्यकता, विकल्प और सुरक्षा की समीक्षा चिकित्सक करते हैं।

> दवा-संबंधी अल्सर को केवल मसाला या दूध की मात्रा बदलकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

6. जोखिम, तनाव और अन्य कारण

Risk, Stress and Other Causes

एच. पाइलोरी और NSAIDs प्रमुख कारण हैं। धूम्रपान, पूर्व अल्सर और कुछ अन्य स्थितियाँ जोखिम या स्वास्थ्यलाभ को प्रभावित कर सकती हैं।

कारक	संबंध
धूम्रपान (Smoking)	अल्सर का जोखिम और भरने की प्रक्रिया प्रभावित
पूर्व अल्सर	पुनः रोग का मूल्यांकन आवश्यक
गंभीर शारीरिक बीमारी	तनाव-संबंधी श्लेष्मिक क्षति संभव
दुर्लभ अम्ल-स्राव संबंधी रोग	विशेष चिकित्सकीय जाँच

मानसिक और शारीरिक तनाव (Psychological and Physiological Stress)

सामान्य मानसिक तनाव तथा गंभीर बीमारी में होने वाली शारीरिक तनाव-प्रतिक्रिया एक ही स्थिति नहीं हैं। सामान्य चिंता को हर पेप्टिक अल्सर का एकमात्र कारण नहीं माना जाता।

दुर्लभ उदाहरण (Uncommon Cause)

ज़ॉलिंगर-एलिसन सिंड्रोम (Zollinger-Ellison Syndrome) में गैस्ट्रिन का अधिक स्राव अम्ल-स्राव बढ़ा सकता है। सामान्य अल्सर में इसे स्वतः कारण नहीं मानते।

> मानसिक स्वास्थ्य और नियमित दिनचर्या का ध्यान उपयोगी है, लेकिन रोग के जैविक कारण की पहचान भी आवश्यक रहती है।

7. लक्षण और भोजन से संबंध

Symptoms and Their Relation to Food

ऊपरी पेट में दर्द या जलन, जल्दी पेट भरना, मितली और असुविधा पेप्टिक रोग में हो सकते हैं। कुछ व्यक्तियों में स्पष्ट लक्षण नहीं होते।

पक्ष	आमाशयी अल्सर	ग्रहणी का अल्सर
स्थान	आमाशय	ग्रहणी
भोजन से संबंध	कुछ में भोजन के बाद दर्द बढ़ सकता है	कुछ में भोजन से अस्थायी आराम
खाली पेट या रात	हो सकता है; रूप बदलता है	दर्द का यह रूप मिल सकता है
निश्चितता	लक्षण अकेले पुष्टि नहीं करते	लक्षण अकेले पुष्टि नहीं करते

पारंपरिक अंतर की सीमा (Limits of the Classical Pattern)

भोजन के बाद दर्द का समय सीखने में सहायता देता है, लेकिन सभी रोगी उसी रूप में प्रस्तुत नहीं होते। केवल इस अंतर से अल्सर का स्थान तय नहीं किया जा सकता।

आहार का मूल्यांकन (Dietary Assessment)

किस भोजन के बाद, कितनी मात्रा में और कितने समय में परेशानी हुई, यह जानकारी योजना में उपयोगी है।

> दर्द का कम होना अल्सर भरने या संक्रमण समाप्त होने की निश्चित पुष्टि नहीं है।

8. रोग की पहचान और परीक्षण

Diagnosis and Investigations

लक्षण, दवा-इतिहास और उपयुक्त परीक्षण रोग के कारण तथा गंभीरता समझने में सहायता करते हैं। बार-बार जलन होने का अर्थ हमेशा अल्सर नहीं है।

जाँच या जानकारी	प्रमुख उपयोग
दवा-इतिहास	NSAIDs तथा अन्य दवाओं का मूल्यांकन
ऊपरी पाचन-मार्ग एंडोस्कोपी (Upper GI Endoscopy)	भीतर की सतह और घाव देखना
ऊतक-जाँच (Biopsy)	आवश्यकता अनुसार घाव का स्वरूप समझना
यूरिया श्वास परीक्षण (Urea Breath Test)	एच. पाइलोरी की पहचान
मल प्रतिजन परीक्षण (Stool Antigen Test)	संक्रमण की जाँच
रक्त संबंधी जाँच	आवश्यकता अनुसार एनीमिया या अन्य परिवर्तन

परीक्षण का चयन (Selecting Tests)

हर व्यक्ति को सभी जाँचें नहीं दी जातीं। आयु, लक्षण, पूर्व रोग और गंभीर संकेतों के अनुसार चयन होता है।

अनुवर्ती जाँच (Follow-Up Testing)

कुछ दवाएँ एच. पाइलोरी परीक्षण को प्रभावित कर सकती हैं। उपचार और जाँच के बीच अंतराल तथा दवाओं में परिवर्तन चिकित्सकीय निर्देश से किए जाते हैं।

> स्वयं लक्षणों या किसी एक रिपोर्ट से पूरी आहार और उपचार-योजना तय नहीं करें।

9. जटिलताएँ और गंभीर संकेत

Complications and Serious Signs

पेप्टिक अल्सर में रक्तस्राव, छिद्रण या भोजन के आगे जाने में अवरोध जैसी जटिलताएँ हो सकती हैं। इनका प्रबंधन सामान्य भोजन-सारणी से अलग है।

स्थिति	प्रमुख संकेत
रक्तस्राव (Bleeding)	रक्त की उलटी या कॉफी-जैसी उलटी
पचा हुआ रक्त	काला, तारकोल जैसा मल
छिद्रण की संभावना (Perforation)	अचानक तेज और लगातार पेट-दर्द
रक्त की अधिक हानि	चक्कर, बेहोशी और अत्यधिक कमजोरी
अवरोध की संभावना (Obstruction)	बार-बार उलटी, पेट भराव और सेवन में कठिनाई

प्राथमिक कार्य (Immediate Action)

ऐसे संकेतों में तुरंत चिकित्सकीय सहायता आवश्यक है। केवल दूध, नरम भोजन या घरेलू उपाय देकर प्रतीक्षा करना उचित नहीं है।

भोजन का मार्ग (Route of Feeding)

गंभीर रक्तस्राव, छिद्रण या अवरोध में भोजन रोकने, फिर शुरू करने और उसके मार्ग का निर्णय चिकित्सकीय दल करता है।

> गंभीर संकेतों में आहार-परिवर्तन उपचार का विकल्प नहीं है। सामान्य नमूना योजना केवल स्थिर और भोजन ग्रहण कर सकने वाले व्यक्ति के लिए है।

10. उपचार और पोषण की अलग भूमिकाएँ

Distinct Roles of Treatment and Nutrition

पेप्टिक अल्सर का उपचार घाव भरने तथा उसके कारण को नियंत्रित करने पर आधारित होता है। आहार पर्याप्त पोषण और स्वीकार्य सेवन बनाए रखने में योगदान देता है।

उपचार का पक्ष	प्रमुख उद्देश्य
अम्ल-स्राव कम करने वाली दवाएँ	घाव भरने के लिए उपयुक्त स्थिति
एच. पाइलोरी का उपचार	संक्रमण का उन्मूलन
दवाओं की समीक्षा	NSAID-संबंधी जोखिम का प्रबंधन
जटिलता का उपचार	रक्तस्राव या अन्य गंभीर स्थिति संभालना
आहार की योजना	पर्याप्त और सहनीय भोजन

सामान्य दवा-वर्ग (Drug Classes)

प्रोटॉन पंप अवरोधक (Proton Pump Inhibitors) और H2 रिसेप्टर अवरोधक (H2 Receptor Blockers) अम्ल-स्राव कम करते हैं। संक्रमण में चिकित्सकीय योजना के अनुसार जीवाणुरोधी दवाएँ दी जाती हैं।

उपचार का पालन (Treatment Adherence)

दवा का चयन और अवधि रोग की स्थिति पर निर्भर करते हैं। लक्षण घटने पर स्वयं उपचार बदलने के स्थान पर निर्धारित योजना का पालन करें।

> पोषण की पर्याप्तता और कारण का उपचार दोनों आवश्यक हैं; किसी एक को दूसरे का विकल्प न बनाएँ।

11. पोषण संबंधी मूल्यांकन

Nutritional Assessment

दर्द के डर से भोजन घटाना, मितली और जल्दी पेट भरना कुल सेवन को कम कर सकते हैं। रोगी की आहार-योजना बनाने से पहले इनका मूल्यांकन करें।

जानकारी	योजना में उपयोग
वजन में बदलाव (Weight Change)	पोषण-कमी का जोखिम
वास्तविक भोजन सेवन	ऊर्जा और प्रोटीन की पर्याप्तता
भूख और पेट भराव	भाग का आकार और आवृत्ति
लक्षण का समय	भोजन से संबंध समझना
हटाए गए पदार्थ	पोषण के वैकल्पिक स्रोत
सहवर्ती रोग (Comorbidities)	विशेष आहार जरूरत

भोजन का भय (Fear of Eating)

हर पदार्थ को नुकसानदायक मान लेने से खाद्य विविधता कम हो सकती है। लक्षण और वास्तविक सहनशीलता को देखकर उचित विकल्प बनाएँ।

वजन घटने का महत्त्व (Unintentional Weight Loss)

अनचाहा वजन घटना केवल आहार की समस्या नहीं माना जाना चाहिए। रोग की स्थिति और संभावित अन्य कारणों की जाँच भी आवश्यक हो सकती है।

> भोजन परोसने की मात्रा के साथ वास्तव में खाया गया भाग भी दर्ज करें। यही कुल सेवन का उपयोगी आधार है।

12. ऊर्जा और प्रोटीन की पर्याप्तता

Energy and Protein Adequacy

स्थिर पेप्टिक अल्सर वाले हर व्यक्ति में अत्यधिक ऊर्जा या प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। आवश्यकता शरीर के आकार, गतिविधि, पोषण-अवस्था और वास्तविक सेवन से तय होती है।

उद्देश्य	आहार का आधार
वजन बनाए रखना	आवश्यकतानुसार ऊर्जा
कम सेवन की भरपाई	छोटे भाग में पोषण-सघनता
ऊतक-कार्य	पर्याप्त प्रोटीन
विविधता	अनेक खाद्य वर्गों का योगदान

प्रोटीन स्रोत (Protein Sources)

दाल, दूध वर्ग, सोया, अंडा और अन्य खाने की आदत के अनुसार स्रोत उपयोग किए जा सकते हैं। उनकी तैयारी सहनशीलता के अनुसार बदलें।

उच्च-प्रोटीन का प्रश्न (High-Protein Diet)

अल्सर ठीक करने के लिए अत्यधिक प्रोटीन देना अनिवार्य नहीं है। ऊर्जा कम हो तो प्रोटीन का कुछ भाग ऊर्जा के लिए भी उपयोग हो सकता है।

भोजन-समृद्धि (Food Enrichment)

नरम दाल, पनीर या अन्य विकल्प जोड़कर छोटे भोजन का पोषण बढ़ाया जा सकता है। केवल मीठा पेय पर्याप्तता नहीं देता।

> रोग के नाम के आधार पर सभी को एक जैसी कैलोरी और प्रोटीन मात्रा निर्धारित न करें।

13. कार्बोहाइड्रेट और वसा

Carbohydrates and Fat

कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates) तथा वसा (Fat) ऊर्जा प्रदान करते हैं। पेप्टिक रोग में इनका चयन सामान्य पोषण जरूरत तथा व्यक्तिगत सहनशीलता के अनुसार किया जाता है।

घटक	संभावित विकल्प	विचारणीय पक्ष
अनाज	चावल, रोटी, दलिया और सूजी	मात्रा तथा तैयारी
दाल के साथ अनाज	खिचड़ी और मिश्रित भोजन	ऊर्जा व प्रोटीन
अतिरिक्त शर्करा	सीमित जरूरत अनुसार	अधिक मीठा जरूरी नहीं
तेल और घी	सामान्य उपयुक्त मात्रा	अधिक चिकनी तैयारी से परेशानी हो सकती है

भारी भोजन (Large or Heavy Meals)

बहुत बड़ा या अधिक चिकना भोजन कुछ लोगों में पेट भराव तथा असुविधा बढ़ा सकता है। मात्रा और तैयारी बदलकर देखें।

सामान्य संतुलन (Dietary Balance)

वसा पूरी तरह बंद करना या केवल स्टार्चयुक्त भोजन देना सार्वभौमिक आहार-योजना नहीं है। अन्य पोषक तत्त्व भी बने रहने चाहिए।

> किसी खाद्य पदार्थ से असुविधा होने का अर्थ यह नहीं कि वही अल्सर बनने का कारण है।

14. आहारीय रेशा

Dietary Fibre

रेशा (Dietary Fibre) अनाज, दालों, फल और सब्जियों में मिलता है। सामान्य पेप्टिक अल्सर में सभी रेशायुक्त पदार्थों को लंबे समय तक बंद करना आवश्यक नहीं है।

पक्ष	मुख्य बात
खाद्य योगदान	रेशा तथा अन्य पोषक तत्त्व
बनावट (Texture)	पका, नरम या कटा रूप सहनशीलता बदल सकता है
मात्रा	बहुत बड़ी मात्रा से कुछ लोगों में पेट भराव
विविधता	अनेक स्रोत रखने का लाभ

नरम और कम रेशा अलग (Soft Diet and Low-Fibre Diet)

अच्छी तरह पका साबुत दलिया नरम हो सकता है, पर उसमें रेशा रहता है। छीलने, छानने और खाद्य भाग हटाने से रेशा बदलता है।

व्यक्तिगत परिवर्तन (Individual Modification)

किसी तैयारी से अधिक गैस या असुविधा हो तो भाग छोटा करें, रूप बदलें या दूसरा विकल्प दें। सभी अनाज और सब्जियाँ हटाना आवश्यक नहीं।

> रेशा पेट के घाव को अनिवार्य रूप से “खरोंचता” है, यह सामान्य निष्कर्ष सही नहीं है। चयन वास्तविक सहनशीलता से करें।

15. दूध और दुग्ध पदार्थ

Milk and Dairy Products

दूध प्रोटीन तथा कैल्शियम देता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर की औषधि नहीं है। बार-बार दूध देकर अम्ल को स्थायी रूप से निष्प्रभावित रखने की धारणा उचित उपचार का विकल्प नहीं है।

पक्ष	स्पष्टता
पोषण	प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य घटक
अस्थायी अनुभूति	कुछ लोगों को थोड़े समय आराम महसूस हो सकता है
अम्ल-स्राव (Acid Secretion)	दूध पीने के बाद अम्ल-स्राव बढ़ भी सकता है
सहनशीलता (Tolerance)	लैक्टोज या अन्य कारण से परेशानी संभव

सामान्य सेवन (Normal Intake)

दूध या दही सहन होने पर संतुलित आहार में रखा जा सकता है। सभी रोगियों में दुग्ध पदार्थ बंद करना और सभी को बहुत अधिक दूध देना, दोनों सार्वभौमिक नियम नहीं हैं।

दही का प्रश्न (Yoghurt)

दही का पोषण योगदान हो सकता है। उसे एच. पाइलोरी समाप्त करने वाला प्रमाणित उपचार न मानें।

> दूध एक खाद्य पदार्थ है। उसकी उपयोगिता पोषण और सहनशीलता से देखें; अल्सर ठीक करने की गारंटी से नहीं।

16. मसाले, पेय और व्यक्तिगत लक्षण

Spices, Drinks and Individual Symptoms

कुछ लोगों में तीखा, अधिक चिकना या किसी विशेष पेय वाला भोजन असुविधा बढ़ा सकता है। यह व्यक्तिगत लक्षण है; सभी के लिए वही पाबंदी आवश्यक नहीं है।

पदार्थ या आदत	योजना का आधार
तीखी तैयारी	परेशानी बढ़े तो तीखापन और मात्रा घटाएँ
चाय या कॉफी	मात्रा तथा लक्षण का संबंध देखें
खट्टा फल या रस	सहनशीलता के अनुसार चयन
मदिरा (Alcohol)	सेवन से बचने की चिकित्सकीय सलाह का पालन
धूम्रपान (Smoking)	छोड़ना जोखिम और स्वास्थ्यलाभ के लिए महत्त्वपूर्ण

कारण और उद्दीपक (Cause and Trigger)

मसालेदार भोजन को पेप्टिक अल्सर का सामान्य मूल कारण नहीं माना जाता। फिर भी किसी व्यक्ति में उससे लक्षण बढ़ें तो तैयारी बदलना उपयोगी हो सकता है।

व्यापक पाबंदी की सीमा (Limits of Blanket Restrictions)

केवल “खट्टा” नाम के आधार पर सभी फल हटाने से खाद्य विविधता घटती है। वास्तविक प्रतिक्रिया देखकर विकल्प रखें।

> उद्दीपक वह पदार्थ या स्थिति है जिससे लक्षण बढ़ें; उद्दीपक और रोग का मूल कारण हमेशा समान नहीं होते।

17. भोजन की बनावट और समय

Food Texture and Meal Timing

सामान्य भोजन सहन होने पर उसे जारी रखा जा सकता है। नरम भोजन कम भूख या चबाने में कठिनाई जैसी स्थितियों में उपयोगी विकल्प है।

स्थिति	संभावित व्यवस्था
बड़ा भोजन असहनीय	छोटे भाग में भोजन
जल्दी पेट भरना	कुल सेवन बनाए रखते हुए आवृत्ति बढ़ाना
कठोर तैयारी असहनीय	नरम, अच्छी तरह पका रूप
पर्याप्त सामान्य सेवन	अनावश्यक तरल आहार की जरूरत नहीं

भोजन की आवृत्ति (Meal Frequency)

छोटे भोजन कुछ लोगों को अधिक स्वीकार्य होते हैं। हर रोगी को निश्चित अंतराल पर लगातार भोजन या दूध देना अनिवार्य नहीं है।

तरल आहार (Liquid Diet)

तरल होने से भोजन स्वतः अल्सर के लिए श्रेष्ठ नहीं हो जाता। बहुत पतला सूप या साफ तरल लंबे समय तक पर्याप्त ऊर्जा और प्रोटीन नहीं देता।

अनावश्यक उपवास (Unnecessary Fasting)

स्थिर रोगी में बिना चिकित्सकीय कारण भोजन रोकने से पोषण-कमी हो सकती है। गंभीर जटिलता का प्रबंधन अलग होता है।

> बनावट और समय का उद्देश्य स्वीकार्य तथा पर्याप्त सेवन है; आमाशय के अम्ल को हमेशा भोजन से ढककर रखना नहीं।

18. खाद्य समूहों से संतुलित चयन

Balanced Selection from Food Groups

आहार में विभिन्न खाद्य समूह रखने से पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्त्व मिलते हैं। एक ही प्रकार का भोजन लंबे समय तक देना पर्याप्त नहीं है।

खाद्य वर्ग	संभावित उदाहरण
अनाज (Cereals)	चावल, रोटी, दलिया और अन्य सहनीय अनाज
दाल और विकल्प (Pulses)	पकी दाल, सोया और मिश्रित तैयारी
दूध वर्ग (Dairy Foods)	दूध, दही और पनीर, सहन होने पर
फल	परिचित और सहनीय फल
सब्जियाँ	पकी या अन्य सहनीय तैयारी
पशुजन्य पदार्थ	पूरी तरह पका अंडा, मछली या अन्य विकल्प
वसा	जरूरत अनुसार सामान्य मात्रा

तैयारी का प्रभाव (Effect of Preparation)

मसाले की तीव्रता, तली हुई सतह और भोजन के भाग को बदलकर उसी खाद्य वर्ग का उपयोग किया जा सकता है।

पर्याप्तता (Adequacy)

अनाज के साथ प्रोटीन स्रोत और फल-सब्जियाँ रखें। केवल सफेद चावल, दूध या बिस्कुट वाला सीमित आहार सामान्य संतुलित योजना नहीं है।

> सूची संभावित विकल्प देती है; किसी एक पदार्थ को सभी रोगियों के लिए अनिवार्य न मानें।

19. लक्षण-अभिलेख और व्यक्तिगत चयन

Symptom Records and Individual Choices

खाद्य अभिलेख से पता लग सकता है कि परेशानी किस पदार्थ, मात्रा या तैयारी से जुड़ी है। इससे अनावश्यक पाबंदियाँ घटाई जा सकती हैं।

दर्ज की जाने वाली बात	उदाहरण
भोजन और तैयारी	दाल, रोटी और अधिक तीखा मसाला
मात्रा (Portion Size)	छोटा भाग या बहुत बड़ा भोजन
समय	भोजन का समय और बाद का अंतराल
लक्षण (Symptoms)	दर्द, जलन, मितली या पेट भराव
अन्य कारक	दवा, तनाव और नींद की स्थिति

एक घटना की सीमा (Limits of a Single Observation)

एक बार भोजन के बाद दर्द होने से वही पदार्थ कारण सिद्ध नहीं होता। रोग की अवस्था तथा साथ खाए गए पदार्थ भी प्रभाव डाल सकते हैं।

क्रमिक बदलाव (Gradual Modification)

भाग छोटा करना, कम तीखी तैयारी या दूसरा प्रोटीन स्रोत जैसे सीमित परिवर्तन करके पर्याप्तता बनाए रखें। गंभीर लक्षणों में प्रयोग करने के स्थान पर उपचार लें।

> अभिलेख योजना में सहायता करता है। यह अल्सर की पुष्टि या एच. पाइलोरी की जाँच का विकल्प नहीं है।

20. नमूना शाकाहारी भोजन-योजना

Sample Vegetarian Meal Plan

यह स्थिर वयस्क के लिए शैक्षणिक उदाहरण है जो मुख से भोजन ले सकता है। भोजन की मात्रा उसकी जरूरत और सहनशीलता के अनुसार तय की जाती है।

समय	संभावित भोजन
सुबह	सुरक्षित पानी और नियमित नाश्ते की तैयारी
नाश्ता	दलिया, इडली या अन्य सहनीय नाश्ता; उपयुक्त प्रोटीन स्रोत
बीच में	सहनीय फल अथवा दही का विकल्प
दोपहर	रोटी या चावल, पकी दाल और सब्जी
शाम	छोटा भोजन; दूध या दूसरा प्रोटीनयुक्त विकल्प
रात	अनाज, दाल या पनीर और उपयुक्त सब्जी

योजना का अनुकूलन (Adapting the Plan)

नरम भोजन अधिक स्वीकार्य हो तो खिचड़ी, नरम दलिया और मसलकर दाल दी जा सकती है। सामान्य भोजन सहन हो तो अनावश्यक रूप से उसे तरल न बनाएँ।

कुल योगदान (Overall Nutrient Intake)

फल, दाल या दूध वर्ग हटाने पर उनके पोषण का उपयुक्त विकल्प दें। वास्तव में खाया गया भाग और दिन का कुल सेवन जाँचें।

> यह रोग-उन्मूलन आहार नहीं है। इसका उद्देश्य सामान्य संतुलित और सहनीय भोजन का उदाहरण देना है।

21. विकल्प और पोषण की भरपाई

Food Alternatives and Nutrient Replacement

असहनीय खाद्य पदार्थ हटाते समय उसकी पोषण-भूमिका पहचानें। खाद्य विकल्प बिल्कुल समान नहीं होते, इसलिए पूरे दिन की योजना देखना आवश्यक है।

परिवर्तन	संभावित विकल्प	क्या देखना चाहिए?
दूध असहनीय	सहनीय दही, लैक्टोज-रहित दूध या अन्य स्रोत	प्रोटीन और कैल्शियम
एक दाल से परेशानी	दूसरी दाल, पनीर, सोया या अंडा	प्रोटीन की पर्याप्तता
कच्चा रूप असहनीय	पकी, छिली या मसलकर तैयारी	विविधता और पोषक योगदान
बड़ा भोजन कठिन	छोटे भाग में वही समूह	दिन का कुल सेवन

मांसाहारी विकल्प (Non-Vegetarian Options)

खाने की आदत के अनुसार पूरी तरह पका अंडा, नरम मछली या अन्य तैयारी रखी जा सकती है। अधिक तली या तीखी तैयारी से परेशानी हो तो रूप बदलें।

वनस्पति पेय (Plant-Based Drinks)

हर वनस्पति पेय दूध जितना प्रोटीन या कैल्शियम नहीं देता। लेबल और खाद्य संरचना देखकर चयन करें।

> हटाने का निर्णय पर्याप्तता बनाए रखने के निर्णय के साथ जुड़ा होना चाहिए।

22. भोजन तैयार करने के सिद्धांत

Principles of Food Preparation

खाना पकाने की विधि और परोसने का भाग भोजन की स्वीकार्यता प्रभावित करते हैं। परिचित घरेलू भोजन को आवश्यकतानुसार सरल तैयारी में बदला जा सकता है।

प्रक्रिया	संभावित लाभ
अच्छी तरह पकाना	अपेक्षित कोमलता और खाद्य सुरक्षा
तीखापन बदलना	लक्षण बढ़ने पर स्वीकार्यता
तली तैयारी में बदलाव	अत्यधिक चिकनाई से असुविधा सीमित करना
छोटा भाग	जल्दी पेट भरने में उपयोगी
भोजन-सघनता (Nutrient Density)	कम मात्रा में पर्याप्त पोषण

नरम करने की सीमा (Limits of Dilution)

भोजन बहुत पतला कर देने से प्रति कटोरी ऊर्जा और प्रोटीन कम हो सकते हैं। पानी बढ़ाना हर स्थिति का उचित समाधान नहीं है।

स्वच्छता (Food Hygiene)

सुरक्षित जल, साफ हाथ, उचित पकाना तथा स्वच्छ भंडारण सामान्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। इन्हें अल्सर की दवा का विकल्प न मानें।

> तैयारी का लक्ष्य स्वाद, पर्याप्तता और सहनशीलता का संतुलन है। सभी व्यंजनों को फीका या छना हुआ बनाना अनिवार्य नहीं है।

23. पारंपरिक और वर्तमान दृष्टिकोण

Traditional and Current Approaches

पेप्टिक अल्सर के लिए पहले दुग्ध-क्षार आधारित तथा अत्यंत सीमित फीके आहार का उपयोग किया जाता था। वर्तमान योजना रोग के कारण के उपचार और पोषण की पर्याप्तता पर केंद्रित है।

पारंपरिक धारणा	वर्तमान स्पष्टता
बार-बार दूध उपचार है	दूध खाद्य पदार्थ है; औषधि नहीं
हर मसाला अल्सर बनाता है	मूल कारण और व्यक्तिगत उद्दीपक अलग हैं
सभी रोगियों का फीका आहार	सहनशीलता अनुसार सामान्य संतुलित आहार
सब्जी और रेशा पूरी तरह रोकें	सार्वभौमिक पाबंदी आवश्यक नहीं
केवल लक्षण घटाना पर्याप्त	कारण और उपचार की सफलता भी देखें

सिप्पी पद्धति (Sippy Regimen)

दूध और क्षार पर आधारित सिप्पी पद्धति ऐतिहासिक उपचार-पद्धति थी। उसे आधुनिक अल्सर-उपचार की सामान्य योजना के रूप में नहीं अपनाया जाता।

अध्ययन का आधार (Interpreting Historical Practice)

पारंपरिक सिद्धांत जानना उपयोगी है, लेकिन ऐतिहासिक उपयोग और वर्तमान चिकित्सकीय उपयुक्तता अलग बातें हैं।

> वर्तमान आहार-योजना में अनावश्यक प्रतिबंध कम रखते हुए पर्याप्त पोषण और व्यक्तिगत सहनशीलता बनाए रखें।

24. स्वास्थ्यलाभ और पोषण-कमी

Recovery and Nutritional Deficiency

उपचार के दौरान भोजन का भय या कम भूख सेवन घटा सकती है। सुधार होने पर स्वीकार्य मात्रा और विविधता धीरे बढ़ाना आवश्यक है।

स्थिति	आवश्यक मूल्यांकन
वजन घट रहा हो	ऊर्जा, वास्तविक सेवन और रोग की स्थिति
कम प्रोटीन सेवन	उचित स्रोत और भोजन-समृद्धि
कमजोरी या एनीमिया	संभावित रक्तस्राव तथा अन्य कारण
भोजन की अनेक पाबंदियाँ	पर्याप्त विकल्प और विविधता
लक्षण कम हुए हों	उपचार तथा अनुवर्ती योजना का पालन

रक्तस्राव और एनीमिया (Bleeding and Anaemia)

अल्सर से लंबे समय कम मात्रा में रक्तस्राव एनीमिया से जुड़ सकता है। केवल आयरनयुक्त भोजन देना रक्तस्राव का उपचार नहीं है। कारण और आवश्यकता अनुसार उपचार करें।

संक्रमण की पुष्टि (Confirming Eradication)

एच. पाइलोरी का उपचार मिलने के बाद उसकी सफलता की जाँच चिकित्सकीय निर्देश के अनुसार की जाती है।

> स्वास्थ्यलाभ का मूल्यांकन केवल दर्द से नहीं; सेवन, वजन, पोषण-अवस्था और रोग के नियंत्रण से करें।

25. संबंधित रोग और विशेष स्थितियाँ

Related Conditions and Special Situations

पेट की जलन, अल्सर, गैस्ट्राइटिस और अम्ल-प्रतिवाह अलग स्थितियाँ हैं। उनके लक्षण मिलते-जुलते हो सकते हैं, पर रोग का स्वरूप एक नहीं है।

स्थिति	मुख्य अंतर
पेप्टिक अल्सर (Peptic Ulcer)	आमाशय या ग्रहणी में घाव
गैस्ट्राइटिस (Gastritis)	आमाशय की श्लेष्मिक परत की सूजन
अम्ल-प्रतिवाह (Acid Reflux)	आमाशय की सामग्री का अन्ननली में लौटना
अपच (Dyspepsia)	अनेक कारणों से होने वाले लक्षणों का समूह

सहवर्ती रोग (Comorbidities)

मधुमेह में भोजन की शर्करा और वितरण देखें। गुर्दे के रोग में प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट या तरल की विशेष जरूरत हो सकती है। सामान्य अल्सर-योजना सीधे लागू न करें।

शल्यक्रिया के बाद (After Surgery)

आमाशय की शल्यक्रिया के बाद छोटी मात्रा, पोषण-कमी या डंपिंग संबंधी विशेष योजना की जरूरत हो सकती है। वह सामान्य अल्सर-आहार से अलग विषय है।

> बच्चों, गर्भवती महिलाओं और विशेष रोग वाले व्यक्तियों की योजना उनकी आयु तथा अवस्था के अनुसार बने।

26. प्रमुख धारणाएँ और पुनरावृत्ति

Common Beliefs and Quick Revision

धारणा	सही समझ
हर अल्सर मसाले से होता है	एच. पाइलोरी और NSAIDs प्रमुख कारण हैं
हर रोगी में अधिक अम्ल होता है	सुरक्षा और मरम्मत का भी महत्त्व है
दूध अल्सर ठीक करता है	दूध पोषण दे सकता है; उपचार नहीं
सभी फल-सब्जियाँ रोकें	चयन वास्तविक सहनशीलता अनुसार
नरम भोजन में रेशा नहीं	बनावट और रेशा अलग आधार हैं
दर्द घटा तो संक्रमण समाप्त	उपचार की सफलता की उचित जाँच आवश्यक

आहार के मुख्य बिंदु (Key Dietary Points)

- पर्याप्त ऊर्जा, प्रोटीन और खाद्य विविधता बनाए रखें।
- किसी पदार्थ से परेशानी हो तो उसकी मात्रा या तैयारी बदलें।
- छोटे भोजन का उपयोग स्वीकार्यता के लिए करें।
- खाद्य विकल्प से पोषण की भरपाई करें।
- गंभीर रक्तस्राव या तेज पेट-दर्द में तुरंत उपचार लें।

> पेप्टिक रोग में कारण का उपचार और भोजन की सहनशीलता दोनों का अध्ययन करें।